

DOLOR IRRUPTIVO

Rafaela Ríos Gallardo

INTRODUCCIÓN

El **dolor irruptivo oncológico** (DIO) se define, según la Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland, como una “exacerbación transitoria del dolor que ocurre tanto espontáneamente como desencadenada por un evento predecible o impredecible, a pesar de un control adecuado del dolor de base”. Esta definición la comparte la European Association for Palliative Care en su documento de consenso sobre el manejo de opioides para el tratamiento del dolor oncológico.

Existen dos tipos de DIO:

- **Incidental:** desencadenado por movimientos voluntarios (caminar, cambios posturales, ...) o involuntarios (tos, defecar, ...) y por procedimientos y cuidados (aseo, curas, ...)
- **Espontáneo:** sin desencadenantes

DIAGNÓSTICO

Dada la importancia de identificar este tipo de dolor, Davies et al publicaron un algoritmo diagnóstico (tabla 1) basado en uno previo de Portenoy et al, en el que se plantean 3 preguntas que pueden ayudar en el diagnóstico diferencial:

- ¿Tiene usted dolor habitualmente?
- ¿Está el dolor basal adecuadamente controlado?
- ¿Presenta usted crisis transitorias de dolor?

Si el paciente contesta sí a las 3 preguntas tiene dolor irruptivo. Según estos criterios, no se considerarían dolor irruptivo:

- Episodios de dolor intenso sin la existencia de dolor basal (**dolor transitorio**).
- Episodios de dolor intenso en un paciente con dolor basal inadecuadamente controlado (**dolor no controlado**).
- Episodios de dolor durante la titulación de una analgesia opioide (**dolor por efecto final de dosis**).

Criterios diagnósticos de dolor irruptivo

- Presencia de dolor basal. Presencia de dolor persistente durante al menos 12 h al día durante la semana previa a la evaluación (o existiría si no tomase analgesia)
- Dolor basal adecuadamente controlado. No hay dolor, o es leve, durante 12 h al día durante la semana previa a la evaluación
- Existencia de exacerbaciones transitorias del dolor

TRATAMIENTO

El tratamiento del DIO es diferente al del dolor crónico. Las características del DIO requiere un fármaco que posea rapidez de acción, duración de efecto corto, potencia analgésica alta, fácil de usar y seguro.

Los **fentanilos transmucosos** (tabla 2) se han diseñado específicamente para esta indicación y a lo largo de los años han aparecido en diferentes presentaciones de citrato de fentanilo, cuya alta liposolubilidad hace que la absorción sea prácticamente inmediata y sus niveles plasmáticos en

sangre muy altos.

Aunque el efecto es similar en todos ellos, hay alguna característica que los diferencia y hace que sea preferido uno u otro en determinados perfiles de pacientes y situaciones.

Fentanilo	Actiq®	Effentora®	Pecfent®	Abstral®	Instanyl®	Breakyl®	Avaric®
Aplicación	Aplicador	Comprimido oral/sl	Espray intranasal	Comprimido SL	Espray intranasal	Película bucal	Comprimido SL
Dosis inicial	200 µg	100 µg	100 µg	100 µg	50 µg	200 µg	133 µg
Tpo. aplicación	15 min	14-25 min	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15-30 min	Inmediato
Tpo. Inicio efecto	15 min	10 min	5 min	10 min	10 min	No referido	6 min
Tpo. máximo	20-40 min	48 min	20 min	22,5-240 min	12-15 min	60 min	60 min
Tpo. 2ª dosis	30 min	30 min	4 horas	15-30 min	10 min	4 horas	15-30 min
Precisa saliva	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí

Características de fentanilos transmucosos disponibles

Fuente: Modificado del manual SEOM de Cuidados Continuos

La **titulación**, alcanzar la dosis eficaz de los distintos fentanilos, es un proceso y no un acto aislado. No existe relación entre la dosis eficaz del fentanilo transmucoso y la dosis del opioide basal, por lo que siempre debemos iniciar el proceso por la dosis más baja e ir titulando. Será distinto para cada fentanilo, según la posología disponible.

Durante la titulación recurrimos al re-dosing, es decir, si es necesario administramos una segunda dosis del producto con un intervalo que varía entre uso 15-30 minutos, según el fármaco.

Debido a su distinta biodisponibilidad, los distintos productos no son bioequivalentes y por lo tanto no son intercambiables. Si queremos cambiar de producto, hay que volver a titular comenzando por la dosis más baja del nuevo producto.

Otro aspecto que se debe de considerar es si existen dos crisis de DIO. Por ello, el intervalo de tiempo establecido entre episodios es de 4 horas para todos los fentanilos (excepto Abstral® que es de solo 2 horas).

A continuación se muestran en la tabla los esquemas de titulación para cada formulación:

Tipo Fentanilo	Nº Episodio	¿Alivio? Si	Dosis	¿Alivio? No, a los 30 min del primero
Oral Transmucoso	Primer episodio	Dosis eficaz 200 µg	200 µg	Re-dosing con 200 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 400 µg	400 µg	Re-dosing con 200/400 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 800 µg	800 µg	Re-dosing con 200/400/800 µg
Comprimido bucal	Primer episodio	Dosis eficaz 100 µg	100 µg	Re-dosing con 100 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 200 µg	200 µg	Re-dosing con 200 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 400 µg	400 µg	Re-dosing con 200 µg
Comprimido sublingual	Primer episodio	Dosis eficaz 100 µg	100 µg	Re-dosing con 100 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 200 µg	200 µg	Re-dosing con 100 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 300 µg	300 µg	Re-dosing con 100 µg
Pulverizador intranasal	Primer episodio	Dosis eficaz 100 µg	100 µg	
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 100 + 100 µg	100 + 100 µg	
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 400 µg	400 µg	

Tipo Fentanilo	Nº Episodio	¿Alivio? Si	Dosis	¿Alivio? No, a los 30 min del primero
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 800 µg	400 + 400 µg	

Titulación distintos fentanilos transmucosos

ALERTA: LO QUE NO SE DEBE OLVIDAR EN URGENCIAS

- Para identificar de forma correcta el DIO, realizaremos las tres cuestiones descritas en el algoritmo de Davies.
- El tratamiento es complementario al tratamiento opiáceo usado para el control del dolor crónico.
- Los fármacos ideales son las distintas formas de fentanilo de liberación rápida.
- El uso de estos fármacos precisa de una titulación de dosis independiente del opiáceo basal.
- Si se manifiestan más de cuatro episodios de DIO al día durante un período de más de cuatro días consecutivos, se debe volver a calcular la dosis del opiáceo de acción prolongada utilizado para el dolor persistente.

5.- BIBLIOGRAFÍA

- The management of cancer-related breakthrough pain: Recommendations of a task group of the Science Committee of the Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. A.N. Davies et al / European Journal of Pain13 (2009) 331-338.
- **Diagnóstico: pautas diagnósticas y la adecuada gestión del dolor basal y del dolor irruptivo. S. García Adrián et al / Med. Palita. 2015; 22 (Supl 1): 10-14.**
- SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017)